

ICD 11 Chapter VI 精神、行為或神經發育障礙分類 Index

精神、行為和神經發育障礙是指個體認知、情緒調節或行為方面出現臨床顯著紊亂的綜合徵，反映了構成精神和行為功能的心理、生物或發育過程的功能障礙。這些障礙通常會帶給患者痛苦，或導致其在個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域受損。

神經發育障礙.....

6A00 智力發展障礙：智力發展障礙是一組起源於發育期病因不同的疾病，其特徵是智力功能和適應性行為明顯低於平均水平，根據適當規範和個人管理的標準化測試，大約低於平均水平兩個或更多的標準差（大約低於2.3 百分位）。如果沒有適當的規範化和標準化測試，智力發展障礙的診斷需要更多地依靠臨床判斷，以適當可比較行為指標評估為基礎。

6A01 發育性言語或語言障礙：發展性言語或語言障礙發生在發育期，其特徵是在理解或產生言語和語言或在語境中使用語言進行交流時遇到困難，超出了預期年齡和智力功能水平的正常變化範圍。觀察到的言語和語言問題不可歸因於區域、社會或文化/民族語言變異，也不能完全由解剖或神經異常來解釋。發育性言語或語言

障礙的假定病因是複雜的，而且在許多個案中，病因不明。

6A02 孤獨症譜系障礙：孤獨症譜系障礙的特徵是持續缺乏啟動和維持社會互動和社會溝通能力，以及一系列限制性、重複性和不靈活的行為、興趣或活動模式，對個人的年齡和社會文化背景而言明顯不典型或過度。此障礙的發病發生在發育期，典型的是在兒童早期，但症狀可能直到以後社會需求超過有限的能力時才完全顯現出來。缺陷嚴重到足以導致個人、家庭、社會、教育、職業或其他重要功能領域損害，而且通常是個人功能的一個普遍特徵，可在所有環境中都可以觀察到，儘管它們可能因社會、教育或其他環境而異。譜系中的個體表現出全方位的智力功能和語言能力。

6A03 發展性學習障礙：發展性學習障礙的特徵是在學習學術技能方面存在嚴重且持續的困難，包括閱讀、寫作或算術。個人在受影響的學術技能方面的表現明顯低於按年齡和一般智力水平的預期，並導致個人學術或職業功能的嚴重損害。發育性學習障礙在學齡早期教授學術技能時首先表現出來。發展性學習障礙並非由於智力發展障礙、感覺障礙（視覺或聽覺）、神經或運動障礙、缺乏教育機會、缺乏對學術指導語言的熟練或社會心理逆境造成的。

6A04 發展性運動協調障礙：發育性運動協調障礙的特徵是在獲得粗大和精細運動技能方面有明顯延遲，在執

行協調運動技能方面有損傷，表現為運動表現的笨拙、遲緩或不準確。根據個人的年齡和智力水平，協調運動技能明顯低於預期水平。協調性運動技能障礙發生在發展期，通常從幼兒時期就明顯存在。協調性運動技能困難導致功能上顯著和持續限制（如日常生活、學校工作、職業和休閒活動方面）。協調運動技能的困難不能完全歸因於神經系統疾病、肌肉骨骼系統或結締組織疾病、感覺障礙，也不能用智力發展障礙解釋。

6A05 注意力不足過動症：注意力不足過動症的特徵是持續的注意力不集中和/或過動衝動（至少 6 個月），對學習、職業或社會功能有直接的負面影響。有證據表明，在 12 歲之前有明顯的注意力不集中和/或過動症-衝動症狀，通常是在兒童早期到中期，儘管有些人可能在後來才首次引起臨床注意。注意力不集中和過動衝動的程度超出了年齡和智力水平的正常變化範圍。注意力不集中是指對不提供高度刺激或頻繁獎勵的任務難以保持注意力，容易分心和有組織問題。過動症是指過度的運動活動和保持靜止困難，在需要行為自我控制的結構化情況下最為明顯。衝動性是指對即時刺激做出反應的傾向，不經過深思熟慮或考慮風險和後果。注意力不集中和過動-衝動特徵的相對平衡和具體表現因人而異，並可能在發展過程中發生變化。為做出診斷，注意力不集中和/或過動-衝動的表現必須在多種情況或環境中明顯存在（如家庭、學校、工作、與朋友或親戚在一起），但可能根據環境結構和要求而變化。症狀不能歸因於另一種精神、行為或神經發育障礙，也不是由於某

種物質或藥物的影響。

6A06 刻板性運動障礙：刻板運動障礙的特徵是在早期發育階段持續（例如持續數月）出現的自願、重複、刻板、明顯無目的（通常是有節奏的）運動，並非由某種物質或藥物的直接生理作用（包括戒斷停藥）引起，並且明顯干擾正常活動或導致自我身體傷害。刻板動作是非傷害性的，可包括身體搖擺，頭部搖晃，彈手指的舉止和拍手。刻板的自我傷害行為可包括重複的頭部撞擊，耳光，戳眼睛，咬手，嘴唇，或其他身體部位。

精神分裂症或其他原發性精神病性障礙.....

6A20 精神分裂症：精神分裂症的特徵是多種心理功能障礙，包括思考（例如妄想、思維混亂）、感知（例如幻覺）、自我體驗（例如感覺自己的感覺、衝動、思想或行為受外力控制）、認知（例如注意力、語言記憶和社會認知受損）、意志（例如動力喪失）、情感（例如情緒喪失）患者可能出現精神運動障礙，包括緊張症。持續性妄想、持續性幻覺、思考障礙以及受他人影響、被動或控制的體驗被認為是核心症狀。症狀必須持續至少一個月才能診斷為精神分裂症。這些症狀並非其他健康狀況（例如腦瘤）的表現，也不是由於某種物質或藥物對

中樞神經系統的影響（例如皮質類固醇）所致，包括戒斷反應（例如酒精戒斷）。

6A21 分裂情感障礙：分裂情感性障礙是一種發作性障礙，其診斷標準為在同一疾病發作期內同時滿足精神分裂症和躁症發作、混合發作或中度/重度憂鬱症發作的症狀，這些症狀可能同時出現，也可能在幾天內相繼出現。精神分裂症的顯著症狀（例如妄想、幻覺、思維混亂、受人影響感、被動和控制感）伴隨中度/重度憂鬱發作（例如情緒低落、興趣喪失、精力減退）、躁狂發作（例如以欣快、易怒或情緒高漲為特徵的極端情緒狀態；活動增多或主觀感覺精力充沛）或混合發作的典型症狀。患者可能出現精神運動性障礙，包括緊張症。所有症狀必須持續至少一個月。這些症狀並非其他疾病（例如腦瘤）的表現，也不是某種物質或藥物（例如皮質類固醇）對中樞神經系統的影響，包括戒斷反應（例如酒精戒斷）。

6A22 分裂型障礙：分裂型人格障礙的特徵是持續存在的行為、外表和言語方面的怪異模式（即至少在數年內持續存在於患者的功能中），並伴隨認知和感知扭曲、異常信念以及對人際關係的不適感（通常伴隨人際關係能力下降）。症狀可能包括情感淡漠或不恰當以及快感缺失。患者可能出現妄想觀念、關係妄想或其他精神病性症狀，包括任何形式的幻覺，但這些症狀的強度或持續時間不足以滿足精神分裂症、分裂情感性障礙或妄想

症的診斷標準。這些症狀會導致患者在個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域遭受痛苦或損害。

6A23 急性短暫性精神病性障礙：急性短暫性精神病性障礙的特徵是精神病性症狀急性發作，無前驅症狀，並在兩週內達到最嚴重程度。症狀可能包括妄想、幻覺、思維混亂、困惑或意識模糊以及情緒和情緒障礙。也可能出現類似緊張症的精神運動性障礙。症狀的性質和強度通常變化迅速，每日甚至一日之內都可能改變。發作持續時間不超過 3 個月，最常見的是持續數天至 1 個月。這些症狀並非其他疾病（例如腦腫瘤）的表現，也不是由某種物質或藥物（例如皮質類固醇）對中樞神經系統的影響所致，包括戒斷反應（例如酒精戒斷）。

6A24 妄想性障礙：妄想症的特徵是出現一種或一系列相關的妄想，通常持續至少 3 個月，且往往更久，且無憂鬱、躁狂或混合性心境發作。妄想的內容因人而異，但通常在個體內部較為穩定，儘管它們可能會隨時間演變。精神分裂症的其他典型症狀（例如清晰且持續的幻覺、陰性症狀、思維混亂或受人影響、被動或控制的體驗）並不存在，但與妄想主題相關的各種感知障礙（例如幻覺、錯覺、人格錯覺）仍然符合診斷。除了與妄想或妄想系統直接相關的行為和態度外，情緒、言語和行為通常不受影響。這些症狀並非其他疾病（例如腦瘤）的表現，也不是某種物質或藥物對中樞神經系統（例如皮質類固醇）的影響，包括戒斷反應（例如酒精戒

斷)。

6A25 原發性精神病性障礙的症狀表現：這些分類可用於描述已確診為精神分裂症或其他原發性精神病性障礙患者的當前臨床表現，但不應用於未確診此類疾病的個體。可應用多個分類。未被歸類為精神、行為或神經發育障礙的健康狀況或損傷（例如腦腫瘤或創傷性腦損傷）的直接病理生理後果所致的症狀，或由物質或藥物對中樞神經系統的直接作用（包括戒斷反應）所致的症狀，不應被視為相應症狀類型的示例。

緊張症.....

6A40 與其他精神障礙有關的緊張症：與另一個精神障礙相關的緊張症是一種主要是精神運動障礙的綜合徵，其特徵是同時出現幾種精神運動活動減少、增加或異常的症狀，發生在另一種精神障礙的背景下，如精神分裂症或其他原發性精神障礙、情緒障礙和神經發育障礙，特別是自閉症譜系障礙。

6A41 物質或藥物所致的緊張症：物質或藥物誘發的緊張症是一種主要為精神運動障礙的綜合徵，其特徵是同時出現精神運動活動減少、增加或異常的幾種症狀，在中毒期間或戒斷某些精神活性物質後不久發生，包括苯環己哌啶（PCP）、大麻、迷幻藥如麥司卡林或 LSD、古柯鹼和 MDMA 或相關藥物，或使用某些精神活性和非

精神活性藥物期間（如抗精神病藥物、苯二氮平、類固醇、雙硫崙、環丙沙星）。

心境障礙.....

6A60 I 型雙極性情感障礙：雙相障礙 I 型是一種發作性心境障礙，其定義是發生一次或多次躁狂或混合發作。躁症發作是一種持續至少一週的極端情緒狀態，除非透過治療介入而縮短，其特徵是欣快、易怒或擴張性，以及活動增加或能量增加的主觀體驗，同時伴隨其他特徵性症狀，如快速或有壓力的說話、思想飛揚、自尊心或自大感增加、睡眠需求減少、分散注意力、衝動或魯莽行為，以及不同情緒狀態之間的變化（即不同情緒狀態）。混合發作的特徵是出現幾個突出的躁症症狀和幾個突出的憂鬱症狀，與躁症發作和憂鬱症發作中觀察到的症狀一致，這些症狀或同時出現，或非常迅速地交替出現（從一天到另一天或在同一天內）。症狀必須包括與躁狂和/或憂鬱發作一致的情緒狀態改變（即憂鬱、焦慮、欣快或擴張性情緒），並且在至少 2 週時間內，幾乎每天都有大部分時間出現，除非透過治療介入縮短。雖然可以根據單一躁狂或混合發作的證據進行診斷，但通常躁症或混合發作與憂鬱症發作在疾病的過程中交替出現。

6A61 雙極性情感障礙 II 型：雙極 II 型障礙是一種發作性心境障礙，定義為一次或多次低躁症發作和至少一

次憂鬱發作。輕躁症發作是一種持續至少幾天的持續性情緒狀態，其特徵是情緒持續高漲或易怒、活動增加或主觀體驗到精力增加，並伴隨其他特徵性症狀，如話語增多、思緒奔湧，自尊心增強、睡眠需求減少、注意力分散，以及衝動或魯莽行為。症狀代表了個體典型情緒、能量水平和行為的變化，但不足以造成明顯的功能損害。憂鬱發作的特徵是在持續至少兩週的時間內，幾乎每天都有一段情緒低落或對活動興趣減退，並伴有其他症狀，如食慾或睡眠改變、精神運動性激越或遲鈍、疲勞、無價值感或過度或不適當的內疚感、感覺或無望、注意力難以集中，以及自殺。沒有躁狂或混合型發作史。

6A62 循環性心境障礙：循環性心境障礙的特徵是在至少兩年內情緒持續不穩定，涉及許多低躁狂（如欣快、易怒或擴張、精神運動性激活）和抑鬱的時期（如情緒低落、對活動興趣減退、疲勞），這些症狀在更多的時間裡存在。低躁症症狀可能或不很嚴重，也可能持續時間不長，不符合躁症發作的全部定義要求（見雙相情感障礙Ⅱ型），但沒有躁症或混合發作史（見雙相情感障礙Ⅰ型）。憂鬱症狀從未嚴重到足以滿足憂鬱症發作的診斷要求（請參閱雙極Ⅱ型障礙）。症狀導致個人、家庭、社會、教育、職業或其他重要功能領域的嚴重痛苦或嚴重損害。

6A70 單次發作憂鬱症：單次發作的憂鬱症的特徵是，當以前沒有憂鬱症發作的病史時，存在或有一次憂鬱症

發作。單發性憂鬱症的特徵是，當沒有既往憂鬱症發作史時，存在或有一次憂鬱症發作。憂鬱發作的特徵是一段時間內情緒低落或對活動興趣減弱，幾乎每天都會發生，持續至少兩週，並伴有其他症狀，如難以集中注意力、無價值感或過度或不適當的內疚、絕望，反復出現死亡或自殺的想法，食慾或睡眠改變，精神運動性躁動或遲鈍，精力減少或疲勞。以前從未出現過任何躁狂、低躁狂或混合發作，這表明存在雙相情感障礙。

6A71 復發性憂鬱症：復發性憂鬱障礙的特徵是有病史或至少兩次憂鬱發作，間隔至少幾個月無明顯情緒障礙。憂鬱發作的特徵是一段時間內情緒低落或對活動的興趣減弱，幾乎每天都會發生，持續至少兩週，並伴有其他症狀，如難以集中注意力、無價值感或過度或不適當的內疚、絕望，反復出現死亡或自殺的想法，食慾或睡眠改變，精神運動性躁動或遲鈍，精力下降或疲勞。以前從未出現過任何躁狂、低躁狂或混合發作，這表明存在雙相情感障礙。

6A72 心境惡劣障礙：惡劣心境障礙的特徵是持續性憂鬱情緒（即持續 2 年或更長），持續一天中大部分時間，而且持續的天數較多。兒童和青少年憂鬱情緒表現為普遍易怒。憂鬱情緒伴隨著其他症狀，如活動興趣或快樂明顯減弱、注意力不集中或猶豫不決、自我價值低或過度或不適當的內疚、對未來無望、睡眠不安或睡眠增加、食慾減弱或增加等，精力不足或疲勞。在疾病的前 2 年，從未有過 2 週時間，其症狀的數量和持續時間

足以滿足憂鬱症發作的診斷要求。沒有躁狂、混合型或低躁症發作史。

6A73 混合型憂鬱和焦慮障礙：混合性憂鬱焦慮障礙的特徵是在兩個星期或更長時間內同時出現焦慮和憂鬱的症狀。憂鬱症症狀包括情緒低落或對活動的興趣或樂趣明顯減弱。有多種焦慮症狀，可能包括感到緊張、焦慮或緊張，無法控制擔憂的想法，擔心可怕事情發生，難以放鬆，肌肉緊張，或交感神經自主症狀。單獨考慮這兩組症狀，其嚴重程度、數量或持續時間都不足以成為診斷另一種憂鬱症或焦慮或恐懼相關疾病的理由。這些症狀在個人、家庭、社會、教育、職業或其他重要的功能領域中導致了嚴重痛苦或嚴重損害。沒有躁狂或混合發作史，表示有雙極性情感障礙。

6A80 心境障礙中，心境障礙發作的症狀和病程表現：在當前憂鬱、躁狂、混合性或低躁症發作的情況下，在發作期間大部分時間都存在突出的、具有臨床意義的焦慮症狀（例如，感到緊張、焦慮，無法控制擔憂的想法，擔心可怕事情發生，難以放鬆，運動緊張，自主神經症狀）。如果在目前憂鬱或混合發作期間出現恐慌發

作，則應單獨記錄當滿足心境障礙和焦慮或恐懼相關障礙的診斷要求時，也應診斷焦慮或恐懼相關障礙。

焦慮或恐懼相關性障礙.....

6B00 廣泛性焦慮障礙：廣泛性焦慮症的特徵是持續數月（通常持續數日）的顯著焦慮症狀，表現為普遍的憂慮（即「遊離性焦慮」）或過度擔憂，這些擔憂集中於多種日常事件，最常涉及家庭、健康、財務、學習或工作，並伴有其他症狀，例如肌肉緊張或躁動不安、交感神經系統過度活躍、感到緊張、不安、情緒緊張、主觀不安或情緒緊張、情緒性緊張、情緒性緊張、情緒性緊張、困難、情緒性情緒、情緒性、情緒性或情緒性困難、情緒性緊張。這些症狀會導致個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域出現顯著的痛苦或嚴重損害。這些症狀並非其他疾病的表現，也不是由某種物質或藥物對中樞神經系統的影響所致。

6B01 驚恐障礙：恐慌症的特徵是反覆出現無法預料的恐慌發作，這些發作並非由特定刺激或情境引起。恐慌發作是短暫的強烈恐懼或焦慮發作，伴隨多種特徵性症狀的快速且同時出現（例如心悸或心跳加快、出汗、顫抖、呼吸急促、胸痛、頭暈或眩暈、發冷、潮熱、瀕死感）。此外，恐慌症的特徵還包括持續擔憂恐慌發作的復發或嚴重性，或採取旨在避免復發的行為，從而導致個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域的

顯著損害。這些症狀並非其他疾病的表現，也不是由某種物質或藥物對中樞神經系統的影響所致。

6B02 廣場恐懼症：廣場恐懼症的特徵是對多種難以逃脫或無法獲得幫助的情境產生顯著且過度的恐懼或焦慮，例如乘坐公共交通工具、身處人群、獨自外出（如在商店、劇院、排隊等）。患者持續對這些情境感到焦慮，因為他們害怕特定的負面後果（例如恐慌症、其他令人喪失能力或尷尬的身體症狀）。他們會主動迴避這些情境，僅在特定情況下（例如有值得信賴的同伴在場）才會進入，或在極度恐懼或焦慮中勉強忍受。這些症狀至少持續數月，且嚴重到足以造成顯著的痛苦或嚴重損害個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域。

6B03 特定恐懼症：特定恐懼症的特徵是，當接觸或預期接觸一種或多種特定物體或情境（例如，接近某些動物、飛行、高處、封閉空間、目睹血液或傷口）時，會持續出現顯著且過度的恐懼或焦慮，這種恐懼或焦慮與實際危險程度不成比例。患者會迴避這些恐懼的物體或情境，或在極度恐懼或焦慮的狀態下忍受。症狀至少持續數月，且嚴重到足以造成顯著的痛苦或嚴重損害，影響患者在個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要方面的功能。

6B04 社交焦慮症：社交焦慮症的特徵是，在一種或多種社交情境中，例如社交互動（如交談）、在被注視的情

況下做事（如在他人面前進食或飲水）或在他人面前表演（如發表演講），持續出現顯著且過度的恐懼或焦慮。患者擔心自己的行為或焦慮症狀會被他人負面評價。他們會持續迴避相關的社交情境，或是在極度恐懼或焦慮的狀態下勉強應對。這些症狀至少持續數月，且嚴重到足以造成顯著的痛苦或對個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域的顯著損害。

6B05 分離焦慮症：分離焦慮症的特徵是對與特定依戀對象分離產生顯著且過度的恐懼或焦慮。在兒童和青少年中，分離焦慮通常集中在照顧者、父母或其他家庭成員身上，而這種恐懼或焦慮程度超越了正常發展階段的範疇。在成人中，分離焦慮通常集中在伴侶或子女身上。分離焦慮的表現可能包括：擔心依戀對象會受到傷害或遭遇不幸事件、不願上學或上班、分離後反覆出現過度痛苦、不願或拒絕與依戀對象分開睡覺，以及反復做關於分離的噩夢。這些症狀至少持續數月，且嚴重到足以導致個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能

領域出現顯著的痛苦或功能障礙。

6B06 選擇性緘默症：選擇性緘默症的特徵是說話時持續存在選擇性，患兒在特定社交場合（通常是在家中）表現出足夠的語言能力，但在其他場合（通常是在學校）則始終無法開口說話。這種障礙持續至少一個月，並非僅限於入學後的第一個月，且嚴重到足以影響學業成績或社交溝通。無法開口說話並非由於缺乏在特定社交場合所需的口語知識或不適應該口語（例如，學校和家庭使用的語言不同）。

強迫症或相關障礙.....

6B20 強迫症：強迫症的特徵是持續存在強迫觀念或強迫行為，或兩者兼具。強迫觀念是指反覆出現且持續存在的想法、圖像或衝動/慾望，這些想法、圖像或慾望具有侵入性、令人不快，並且通常伴隨著焦慮。患者會試圖忽略或壓制強迫觀念，或透過強迫行為來消除它們。強迫行為是指重複性的行為，包括重複性的心理活動，患者覺得必須按照嚴格的規則或為了獲得某種「完整感」而進行這些活動。要診斷為強迫症，強迫觀念和強迫行為必須耗費大量時間（例如每天超過一小時），或導致患者在個人、家庭、社交、教育、職業或其他重

要功能領域中出現顯著的痛苦或嚴重損害。

6B21 軀體變形障礙：軀體變形障礙的特徵是持續專注於一個或多個感知到的外貌缺陷或瑕疵，這些缺陷或瑕疵對他人來說要么難以察覺，要么只是輕微可見。患者會過度在意自己的外貌，常常伴隨關係妄想（即堅信他人正在註意到、評斷或討論這些感知到的缺陷或瑕疵）。為了應對這種過度關注，患者會表現出重複且過度的行為，包括反覆檢查感知到的缺陷或瑕疵的外觀或嚴重程度，過度嘗試掩蓋或改變這些缺陷或瑕疵，或明顯迴避會加劇其對缺陷或瑕疵感到痛苦的社交場合或觸發因素。這些症狀嚴重到足以導致患者在個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域遭受顯著痛苦或嚴重損害。

6B22 嗅覺牽連障礙：嗅覺參照障礙的特徵是持續地認為自己散發著難聞或令人不快的體味或呼吸氣味，而這種氣味對他人來說要麼難以察覺，要麼只有輕微的察覺。患者會過度在意這種感知到的氣味，常常伴隨著參照觀念（即確信別人正在註意到、評斷或談論這種氣味）。為了回應這種執念，患者會表現出重複且過度的行為，例如反覆檢查體味或尋找氣味的來源，反覆尋求安慰，過度嘗試掩蓋、改變或阻止這種感知到的氣味，或明顯迴避會加劇對這種難聞或令人不快氣味的社交場合或觸發因素。這些症狀嚴重到足以導致患者在個人、家

庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域遭受顯著痛苦或嚴重損害。

6B23 疑病症：疑病症的特徵是對患有一種或多種嚴重、進行性或危及生命的疾病持續存在擔憂或恐懼。這種擔憂通常伴隨以下兩種情況之一：1) 反覆且過度的健康相關行為，例如反覆檢查身體尋找疾病跡象、花費大量時間搜尋有關所恐懼疾病的資訊、反覆尋求安慰（例如安排多次就醫）；或 2) 與健康相關的適應不良的迴避行為（例如逃避就醫）。這些症狀會導致患者在個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域遭受顯著痛苦或嚴重損害。

6B24 囤積症：囤積症的特徵是物品的過度堆積，導致居住空間雜亂不堪，以至於影響其使用或安全。囤積行為的發生既源自於反覆的囤積衝動或行為，也源自於難以丟棄物品的心理障礙，病人既有保存物品的需要，又因丟棄物品而感到痛苦。如果居住空間保持整潔，則完全是由於第三方（例如家庭成員、清潔工、相關部門）的介入。囤積行為可以是被動的（例如囤積收到的傳單或郵件），也可以是主動的（例如過度獲取免費、購買或偷竊的物品）。這些症狀會導致患者在個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域遭受嚴重的痛苦或損害。

6B25 以身體為中心的重複行為障礙：以身體為中心的重複性行為障礙的特徵是反覆出現針對皮膚的習慣性行

為（例如拔毛、摳皮、咬嘴唇），通常伴隨著試圖減少或停止這些行為但未成功的嘗試，並最終導致皮膚後遺症（例如脫髮、皮膚損傷、嘴唇擦傷）。這些行為可能以短暫發作的形式在一天中零星出現，也可能以頻率較低但持續時間較長的形式出現。這些症狀會導致患者在個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域中

出現顯著的痛苦或嚴重損害。

壓力相關障礙.....

6B40 創傷後壓力症候群：創傷後壓力症候群（PTSD）可能在經歷極度危險或恐怖的事件或一系列事件後出現。其特徵包括以下所有面向：1）在當下以生動的侵入性記憶、閃回或惡夢的形式重新體驗創傷事件。這種重新體驗可能透過一種或多種感官方式發生，通常伴隨強烈或難以承受的情緒，尤其是恐懼或驚恐，以及強烈的身體感覺；2）迴避對事件的思考和記憶，或迴避與事件相關的活動、情境或人物；3）持續感知到當前威脅加劇，例如表現為過度警覺或對意外噪音等刺激的驚恐反應增強。這些症狀至少持續數週，並對個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域造成顯著損害。

6B41 複雜性創傷後壓力症候群：複雜性創傷後壓力症候群（複雜性 PTSD）是一種在經歷一次或一系列極具威脅性或恐怖性質的事件後可能出現的障礙，最常見的是持續時間長或反覆發生的事件，且難以或不可能逃脫（例如酷刑、奴役、種族滅絕、長期家庭暴力、反覆的童年性虐待或身體虐待）。患者符合所有創傷後壓力症候群（PTSD）的診斷標準。此外，複雜性 PTSD 的特徵還包括：1）嚴重的持續性情緒調節障礙；2）自我認知受損，認為自己低人一等、失敗或毫無價值，並伴隨與創傷事件相關的羞恥感、內疚感或失敗感；3）難以維持人際關係，難以與他人建立親密關係。這些症狀會對個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域造成顯著損害。

6B42 持續性悲傷障礙：持續性哀傷障礙是指在伴侶、父母、子女或其他親近之人去世後，出現持續且廣泛的哀傷反應，其特徵是對逝者的思念或持續的對逝者的過度關注，並伴有強烈的精神痛苦（例如悲傷、內疚、憤怒、否認、自責、難以接受死亡、感覺失去了自我的一部分、無法體驗積極、其他情緒）。這種哀傷反應在喪親後持續的時間異常長（至少超過 6 個月），並且明顯超出個人文化和背景所預期的社會、文化或宗教規範。如果哀傷反應持續時間較長，但仍在個人文化和宗教背景下正常的哀傷期內，則被視為正常的喪親反應，不予診斷。這種疾病會對個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要領域的功能造成嚴重損害。

6B43 適應障礙：適應障礙是對可識別的一種或多種社會心理壓力源（例如離婚、疾病或殘疾、社會經濟問題、家庭或工作衝突）的一種適應不良反應，通常在壓力源出現後一個月內出現。此障礙的特徵是對壓力源或其後果過度關注，包括過度擔憂、反覆出現與壓力源相關的痛苦想法，或持續反芻其影響，以及無法適應壓力源，從而導致個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域的顯著損害。這些症狀不能用其他精神障礙（例如心境障礙、其他與壓力相關的障礙）來更好地解釋，並且通常會在 6 個月內消退，除非壓力源持續時間更長。

6B44 反應性依戀障礙：反應性依附障礙的特徵是幼兒時期出現嚴重異常的依附行為，而這種行為通常發生在兒童早期嚴重缺乏照顧（例如，嚴重忽視、虐待、機構照顧缺失）的背景下。即使新近出現合適的照顧者，患兒也不會向其尋求安慰、支持和關愛，很少對任何成年人表現出安全感，並且對他人提供的安慰也無動於衷。反應性依附障礙只能在兒童時期診斷，其症狀通常在生命的前 5 年內發展。然而，在 1 歲之前（或發展年齡小於 9 個月），由於選擇性依附的能力可能尚未完全發育成熟，或在合併自閉症譜系障礙的情況下，無法診斷出該障礙。

6B45 去抑制性社交參與障礙：去抑制性社交障礙的特徵是嚴重的社交行為異常，通常發生在兒童時期遭受嚴重忽視（例如，嚴重疏忽、機構照顧不足）的情況下。患童會不加選擇地接近成人，缺乏主動親近的意識，會跟隨陌生成人離開，並且對陌生人表現出過度親密的行為。去抑制性社交障礙只能在兒童時期診斷，其症狀通常在生命的前 5 年內發展。然而，在 1 歲（或發育年齡小於 9 個月）之前，由於選擇性依附能力可能尚未完全發育成熟，或在合併自閉症譜系障礙的情況下，無法診斷出該障礙。

分離障礙.....

6B60 分離性神經症狀障礙：分離性神經症狀障礙的特徵是出現運動、感覺或認知症狀，這些症狀顯示運動、感覺或認知功能的正常整合出現非自主性中斷，且與已知的神經系統疾病、其他精神或行為障礙或其他醫學狀況不符。這些症狀並非僅在其他分離性障礙期間出現，也並非由物質或藥物對中樞神經系統的影響（包括戒斷反應）或睡眠-覺醒症所引起。

6B61 分離性失憶症：分離性遺忘症的特徵是無法回憶起重要的自傳體記憶，通常是近期發生的創傷性或壓力事件，這與普通的遺忘不符。這種遺忘症並非僅在其他分離性障礙期間出現，也不能用其他精神、行為或神經發育障礙來更好地解釋。這種遺忘症並非由物質或藥物對中樞神經系統的直接作用（包括戒斷反應）引起，也並非由神經系統疾病或頭部外傷引起。這種遺忘症會導致個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域的顯著損害。

6B62 催眠障礙：恍惚狀態的特徵是個體意識狀態發生顯著改變，或喪失其慣常的個人身份認同感，表現為對周圍環境的感知範圍縮小，或異常地、選擇性地關注環境刺激，以及動作、姿勢和言語受限，只能重複少數幾種不受控制的行為模式。恍惚狀態的特質並非體驗到被另一種身分所取代。恍惚發作反覆出現；如果診斷是基於單次發作，則該發作至少持續數天。恍惚狀態是非自願的、不受歡迎的，也不被任何集體文化或宗教習俗所接受。這些症狀並非僅在其他分離性障礙期間出現，也無法用其他精神、行為或神經發育障礙更好地解釋。這些症狀並非由物質或藥物對中樞神經系統的直接作用所引起，包括戒斷反應、疲勞、入睡期或起床期狀態，也並非由神經系統疾病、頭部外傷或睡眠覺醒症所引起。這些症狀會導致個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域出現顯著的痛苦或嚴重損害。

6B63 附身恍惚障礙：附身恍惚狀態的特徵是意識狀態發生顯著改變，個體的意識狀態發生顯著改變，其通常的個人身份認同被外部的「附身」身份所取代，並且個體感覺自己的行為或動作受到附身者的控制。附身恍惚狀態反覆發作，或者，如果診斷基於單次發作，則該發作至少持續數天。附身恍惚狀態是非自願的、不受歡迎的，也不被任何集體文化或宗教習俗所接受。這些症狀並非僅在其他分離性障礙期間出現，也不能用其他精神、行為或神經發育障礙來更好地解釋。這些症狀並非由物質或藥物對中樞神經系統的直接作用（包括戒斷反應、疲勞）或入睡期或起床期狀態引起，也不是由神經系統疾病或睡眠-覺醒障礙引起。這些症狀會導致個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域出現嚴重的痛苦或嚴重損害。

6B64 分離性別認同障礙：分離性認同障礙的特徵是認同的紊亂，表現為兩種或兩種以上截然不同的人格狀態（分離性認同），並伴隨自我意識和自主性的顯著斷裂。每種人格狀態都包含其獨特的體驗、感知、構想和與自我、身體和環境建立關係的模式。至少兩種截然不同的人格狀態會反覆控制個體的意識和功能，例如在與他人或環境互動時，在履行日常生活中的特定職責（如育兒或工作）或應對特定情境（例如，被感知為威脅的情境）時。人格狀態的改變伴隨著感覺、知覺、情緒、認知、記憶、運動控制和行為的相應改變。患者通常會出現失憶發作，有時失憶症狀可能很嚴重。這些症狀無法用其他精神、行為或神經發育障礙更好地解釋，也不是由物質或藥物對中樞神經系統的直接作用（包括戒斷反應）引起的，更不是由神經系統疾病或睡眠-覺醒障礙導致。這些症狀導致患者在個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域中出現顯著障礙。

6B65 部分分離性別認同障礙：部分分離性認同障礙的特徵是認同的紊亂，表現為兩種或多種截然不同的人格狀態（分離性認同），並伴隨自我意識和自主意識的顯著斷裂。每種人格狀態都包含其自身獨特的體驗、感知、構想和與自我、身體及環境建立關係的模式。其中一種人格狀態占主導地位，通常在日常生活中發揮作用，但會受到一種或多種非主導人格狀態（分離性入侵）的干擾。這些入侵可能是認知、情緒、知覺、運動或行為方面的。它們會被體驗為干擾主導人格狀態的功能，並且通常會帶來厭惡感。非主導人格狀態不會反覆控制個體的意識和功能，但可能偶爾會出現短暫且有限的發作，在此期間，一種特定的人格狀態會佔據主導地位，從而進行一些特定的行為，例如在極端情緒狀態下、自殘行為或重現創傷記憶時。這些症狀無法用其他精神、行為或神經發育障礙更好地解釋，也不是由物質或藥物對中樞神經系統的直接影響（包括戒斷反應）所致，更不是由神經系統疾病或睡眠-覺醒障礙引起。這些症狀會導致個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域出現顯著損害。

6B66 人格解體-現實解體障礙：人格解體-現實解體障礙的特徵是持續或反覆出現人格解體、現實解體或兩者兼有的體驗。人格解體的特徵是體驗到自我陌生或不真實，或感覺與自身的想法、感受、感覺、身體或行為脫節，如同置身事外的旁觀者。現實解體的特徵是體驗他人、物件或世界陌生或不真實（例如，如夢似幻、遙遠、模糊、死氣沉沉、蒼白無色或視覺扭曲），或感覺與周圍環境脫節。在人格解體或現實解體體驗期間，現實檢驗能力保持完好。人格解體或現實解體的經驗並非僅發生於其他分離性障礙期間，且不能用其他精神、行為或神經發育障礙來更好地解釋。人格解體或現實解體的經驗並非由物質或藥物對中樞神經系統的直接作用（包括戒斷反應）引起，也並非由神經系統疾病或頭部外傷引起。這些症狀會導致個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域出現嚴重的痛苦或損害。

餵食或進食障礙.....

6B80 神經性厭食症：神經性厭食症的特徵是與個人身高、年齡和發育階段相比，體重明顯偏低，不是由於其他健康狀況或無法獲得食物所致。常用閾值是成人的體重指數（BMI）低於 18.5kg/m^2 ，兒童和青少年的 BMI-年齡低於第五百分位。只要符合其他診斷要求，快速減重（如 6 個月內超過總體重的 20%）可以取代低體重的準則。兒童和青少年可能表現出未能按照預期的個人發展軌跡增加體重，而不是體重下降。低體重伴隨著持續的行為模式，以防止恢復正常體重，這可能包括旨在減少能量攝入的行為（限制飲食），清除行為（如自我誘導嘔吐，濫用瀉藥），以及旨在增加能量消耗的行為（如過度運動），通常與擔心體重增加有關。低體重或體形是該人自我評價的核心，或被不準確地認為是正常的，甚至是過度的。

6B81 心因性貪食症：心因性貪食的特徵是頻繁、反覆發作的暴飲暴食（例如，在至少一個月的時間內，每週一次或更多）。暴飲暴食發作是一個明顯的時期，在此期間，個人體驗到對飲食的主觀失控，飲食明顯多於或不同於平常，並感到無法停止進食或限制食物的種類或數量。暴飲暴食伴隨著反覆不適當的代償行為，旨在防止體重增加（如自我誘導嘔吐，濫用瀉藥或灌腸，劇烈運動）。個人對體型或體重斤斤計較，強烈影響自我評價。對暴飲暴食的模式有明顯的困擾，並有不適當的補償行為，或在個人、家庭、社會、教育、職業或其他重要功能領域有明顯的損害。個人不符合神經性厭食症的診斷要求。

6B82 暴食症：暴飲暴食症的特徵是頻繁、反覆發作的暴飲暴食（例如在幾個月內每週一次或更多）。暴飲暴食發作是一段明顯時期，在此期間，患者主觀上對飲食失去控制，飲食明顯明顯多於或不同於平時，並感到無法停止進食或限制食物的種類或數量。暴飲暴食是一種非常痛苦的體驗，並經常伴隨著如內疚或厭惡等負面情緒。然而，與貪食症不同的是，暴飲暴食發作後並不經常出現旨在防止體重增加的不適當的補償行為（如自我誘導嘔吐、濫用瀉藥或灌腸劑、劇烈運動）。對暴飲暴食的模式有明顯的苦惱，或在個人、家庭、社會、教育、職業或其他重要的功能領域有明顯的損害。

6B83 迴避-限制性食物攝取障礙：迴避限制性食物攝取障礙（ARFID）的特徵是迴避或限制食物攝入，從而導致。 1) 攝取的食物數量或種類不足以滿足足夠的能量或營養需求，導致體重明顯下降，臨床上出現明顯的營養缺乏，依賴口服營養補充劑或管飼，或對個人身體健康產生負面影響；或 2) 在個人、家庭、社會、教育、職業或其他重要的功能領域出現明顯損害（例如，由於迴避或與參與涉及飲食的社會經歷有關的痛苦）。飲食行為的模式不是出於對體重或體型的關注。限制食物攝取及其對體重、健康的其他方面或功能的影響不是由於無法獲得食物，不是其他疾病（如食物過敏、甲狀腺機能亢進）或精神障礙的表現，也不是由於某種物質或藥物對中樞神經系統的影響，包括戒斷效應。

6B84 異食癖：異食癖的特徵是經常食用非營養物質，如非食物的物體和材料（如粘土、土壤、粉筆、石膏、塑膠、金屬和紙張）或食物原料（如大量的鹽或玉米粉），這種行為持續或嚴重到需要臨床關注的程度，而這些人已經達到可以區分食用和非食用物質的發育年齡（大約 2 歲）。也就是說，該行為對健康造成損害，功能受損，或因攝取的物質或物品的頻率、數量或性質而造成重大風險。

6B85 反芻-逆流障礙：反芻-逆流障礙的特徵是有意和反覆將先前吞下的食物帶回口腔（即反芻），這些食物可能會被再次咀嚼和吞下（即反芻），也可能被故意吐出（但不像嘔吐）。反芻行為是頻繁的（每周至少幾次），並持續了至少數週時間。另一種直接導致返流（如食道狹窄或影響食道功能的神經肌肉疾病）或導致噁心或嘔吐（如幽門狹窄）的疾病不能完全解釋返流行為。反芻-逆流障礙只能在發育年齡至少達到 2 歲的個體中診斷。

排泄障礙.....

6C00 遺尿症：遺尿症是指已達到通常預期控尿發育年齡（5 歲）的人，反覆將尿液排到衣服或床上，這可能發生在白天或夜間。尿失禁可能在出生時就已存在（即正常嬰兒尿失禁的非典型延伸），也可能是在後天性膀胱控制後出現。在大多數情況下，這種行為是不自主的，但在某些情況下似乎是故意的。如果無意排尿是由於健康狀況（如神經系統疾病或肌肉骨骼疾病）或先天性或後天性泌尿道異常造成的，則不應診斷為遺尿症。

6C01 遺糞症：遺糞症是在不適當的地方重複排便。如果在已達到通常預期控制便發育年齡（4 歲）的個體中反覆出現不適當的排便（例如，幾個月內至少每月一次），則應診斷為遺糞症。大便失禁可能是出生時出現的（即正常嬰兒失禁的非典型延伸），也可能是在獲得性大便控制一段時間後出現。如果糞便污染完全歸因於其他健康狀況（如無神經節性巨結腸、脊柱裂、失智症）、先天性或後天性腸道異常、胃腸道感染或過度使用瀉藥，則不應診斷為遺糞症。

軀體不適或身體體驗障礙.....

6C20 軀體不適障礙：軀體不適障礙的特徵是存在令個人痛苦的身體症狀，以及對症狀的過度關注，這可能表現為反覆與醫療保健提供者接觸。如果另一個健康狀況引起或促成了這些症狀，那麼相對於其性質和進展，關注的程度顯然是過度的。過度關注不能透過適當的臨床檢查和調查以及適當的安撫來緩解。身體症狀是持續的，在大多數日子至少持續幾個月。通常情況下，身體不適障礙涉及多種身體症狀，這些症狀可能隨時間變化。偶爾會有一個單一的症狀-通常是疼痛或疲勞-與該障礙的其他特徵有關。這些症狀和相關的苦惱和關注至少對個體的功能產生了一些影響（如人際關係緊張，學習或職業功能的效率降低，放棄特定的休閒活動）。

6C21 身體一致性煩惱：軀體完整性躁動的特徵是強烈而持久地希望自己在某種程度上成為身體殘疾者（如主要肢體截肢者、截癱、失明），在青春早期發病，並伴有持續不適感，或對目前非殘疾的身體構造有強烈不適感。對身體殘疾的渴望導致了有害的後果，表現為對這種渴望的關注（包括花時間假裝殘疾）嚴重干擾了生產力、休閒活動或社會功能（例如，此人不願意有親密關係，因為這將使他難以假裝），或者試圖真正成為殘疾人，導致此人的健康或生命受到嚴重威脅。這種障礙不能由另一種精神、行為或神經發育障礙、神經系統疾病或另一種醫療狀況或裝病來更好地解釋。

物質使用或成癮行為所致障礙.....

1.物質使用所致障礙

6C40 酒精使用所致障礙：酒精使用所致障礙是以飲酒的模式和後果為特徵。酒精--更確切地說是乙醇--是一種令人陶醉的化合物，通常由水果、穀物和蔬菜等農產品中的醣類發酵產生，有或沒有後續蒸餾。酒精飲料種類繁多，酒精濃度通常在 1.5%至 60%之間。酒精主要是一種中樞神經系統抑制劑。除了能夠產生酒精中毒外，酒精還具有產生依賴性的特性，導致一些人產生酒精依賴，當減少或停止飲酒時，會出現酒精戒斷。與大多數其他物質不同，酒精從體內消除速度是恆定的，因此酒精的清除遵循線性過程而不是對數過程。酒精對身體的大多數器官和系統都有廣泛的危害（如肝硬化、胃腸道癌症、胰臟炎）。酒精中毒期間的行為對他人造成的傷害是公認的，並包含在有害使用酒精的定義中（即有害使用酒精的事件和有害使用酒精的模式）。一些由酒精引起的精神障礙（如酒精誘發的精神病障礙）和與酒精有關的神經認知障礙（如因飲酒導致的癡呆）已被確認。

6C41 大麻素類物質使用所致障礙：使用大麻所致疾病的特徵是使用大麻的模式和後果。大麻是大麻植物、大麻、相關物種和雜交種的一系列精神活性製劑的統稱。大麻含有大麻素，這是一類作用於內源性大麻素受體的多種化合物，調節大腦中神經傳導物質釋放。主要的精神活性大麻素是 δ -9-四氫大麻酚（THC）。通常以大麻植物的花頭或葉子的形式被吸食；吸食時，菸草常與大麻混合。也有大麻油從這些相同來源製備。這些製劑在四氫大麻酚的效力上差異很大。大麻主要具有中樞神經系統抑製作用，並產生一種特有欣快感，這可能是大麻中毒的部分錶現特徵，也可能包括認知和精神運動功能受損。大麻具有產生依賴性的特性，導致一些人對大麻產生依賴，在減少或停止使用時出現大麻戒斷現象。大麻與一系列大麻誘發的精神障礙有關。

6C42 合成大麻素類物質使用所致障礙：合成大麻素所致疾病是以合成大麻素的使用模式和後果為特徵的。合成大麻素是合成的多種化學化合物，是內源性大麻素受體的強效激動劑。這種化合物有幾百種。合成化合物通常噴在大麻或茶葉等載體上，然後被吸食。這些化合物的作用明顯不同於吸食天然種植的大麻，因為欣快效應通常伴隨或主要是精神病樣症狀（例如，偏執、幻覺和無序行為）。因此，合成大麻素中毒除了大麻更典型的作用外，還可能更頻繁地出現精神病症狀。合成大麻素也會產生依賴性，合成大麻素依賴性和合成大麻素戒斷也被認可。合成大麻素引起的精神障礙也會發生；尤其是合成大麻素引起的精神病性障礙是公認的。

6C43 阿片類物質使用所致障礙：阿片類藥物使用所致疾病以阿片類藥物使用模式和後果為特徵。鴉片類物質是一個通用術語，包括罌粟成分或衍生物，以及一系列合成和半合成化合物，其中一些與嗎啡有關，有些化學性質不同，但都主要作用於 μ 阿片受體。鴉片類藥物包括嗎啡、二乙醯嗎啡（海洛因）、芬太尼、哌替啶、羥考酮、氫嗎啡酮、美沙酮、丁丙諾啡、可待因和 d-丙氧芬。阿片類藥物都具有不同效力的鎮痛特性，主要是中樞神經系統抑制劑。它們抑制呼吸和其他重要功能，是過量服用和相關死亡的常見原因。某些鴉片類藥物經由非腸道途徑使用或施用，包括海洛因，這是一種常見且強效鴉片類藥物，主要用於非醫療用途。治療性鴉片類藥物在世界各地有多種適應症，對癌症疼痛和安寧療護中的疼痛管理至關重要，儘管它們也用於非治療性原因。在一些國家，與治療性鴉片類藥物有關的發病率和死亡率高於與海洛因有關的發病率和死亡率。所有鴉片類藥物均可導致鴉片類藥物中毒、鴉片類藥物依賴和鴉片類藥物戒斷。出現一系列阿片類藥物使用所致疾病，其中一些發生在阿片類藥物戒斷後。

6C44 鎮靜、催眠或抗焦慮藥物使用所致障礙：使用鎮靜劑、催眠藥或抗焦慮藥所致疾病的特徵是使用這些物質的模式和後果。鎮靜劑、安眠藥和抗焦慮藥通常用於短期治療焦慮或失眠，也用於為醫療操作提供鎮靜。它們包括苯二氮平類和非苯二氮平類 GABA 受體正向別構調節劑（即"Z 藥"）以及許多其他化合物。鎮靜劑、安眠藥和抗焦慮藥包括巴比妥類藥物，與過去幾十年相比，巴比妥類藥物現在的使用頻率要低得多。鎮靜劑、安眠藥和抗焦慮藥具有誘導依賴的特性，這與它們的使用劑量和持續時間有關。它們可能會導致中毒、依賴和戒斷。其他幾種由鎮靜劑、安眠藥或抗焦慮藥引起的精神障礙也被確認。

6C45 可卡因使用所致障礙：可卡因使用所致障礙以可卡因使用模式和後果為特徵。可卡因是古柯植物葉子中發現的一種化合物，該植物原產於南美洲北部地區。可卡因作為一種麻醉劑和血管收縮劑有限用於醫學治療。它通常被非法使用，並在世界各地廣泛存在，有兩種主要形式：鹽酸可卡因和精煉可卡因（也被稱為"強效可卡因"）。可卡因是一種中樞神經系統興奮劑，可卡因中毒通常包括欣快和過動狀態。可卡因具有強烈的產生依賴性的特性，可卡因依賴是疾病和臨床表現的常見原因。可卡因戒斷有一個特徵性過程，包括嗜睡和憂鬱情緒。描述了一系列可卡因誘發的精神障礙。

6C46 興奮劑（包括苯丙胺類、甲基安非他命或甲卡西酮）使用所致障礙：興奮劑（包括苯丙胺類、甲基安非他命或甲卡西酮）使用所致障礙的特徵是使用這些物質的模式和後果。除可卡因外，還有大量自然產生和合成的精神刺激劑。其中數量最多的是安非他明類物質，包括甲基安非他命。包括右安非他命在內的處方興奮劑適用於少數情況，如注意力不足過動症。甲卡西酮在許多國家被稱為麻黃酮，是一種合成強效興奮劑，是甲基安非他命的結構類似物，與卡西酮有關。所有這些藥物主要具有精神刺激性，也是不同程度的血管收縮劑。它們會引起欣快感和過動，可見於興奮劑中毒。它們具有強烈的依賴性，這可能導致診斷為精神興奮劑依賴和停止使用後的興奮劑戒斷。描述了幾種由興奮劑所致的精神障礙。

6C47 合成卡西酮類物質使用所致障礙：合成卡西酮類物質使用所致障礙的特徵是使用合成卡西酮類的模式和後果。合成卡西酮（又稱「浴鹽」）是一種具有興奮劑特性的合成化合物，與卡塔葉植物中的卡西酮有關。在許多國家，使用合成卡西酮在年輕族群中很常見。合成卡西酮可能產生一系列紊亂，包括合成卡西酮中毒、合成卡西酮依賴和合成卡西酮戒斷。有幾種合成卡西酮引起的精神障礙已被確認。

6C48 咖啡因使用所致障礙：咖啡因使用所致障礙以咖啡因的使用模式和後果為特徵。咖啡因是一種溫和的精神興奮劑和利尿劑，存在於咖啡豆中，是咖啡、可樂飲料、巧克力、一系列專有「能量飲料」和減肥藥的成分。是世界上最常用的精神活性物質，並描述了與其使用相關的幾種臨床狀況，儘管考慮到其普遍性，嚴重病症還是相對罕見。咖啡因中毒與攝取較高劑量（即每天>1 克）有關。長期或大量使用咖啡因的人在停止使用咖啡因後出現戒斷症狀。咖啡因誘發焦慮症也有描述，通常是在中毒或大量使用後出現。

6C49 致幻劑使用所致障礙：迷幻藥使用所致障礙的特徵是致幻劑使用的模式和後果。數千種化合物具有致幻特性，其中許多存在於植物（如墨斯卡林）和真菌（如裸蓋菇素）中，或者是化學合成的（如麥角酰二乙胺[LSD]）。這些化合物主要具有致幻特性，但有些也可能是興奮劑。與這些化合物相關的大部分發病率來自與致幻劑中毒相關的急性作用。致幻劑依賴罕見，且無描述致幻劑戒斷。在與使用致幻劑有關的精神障礙中，致幻劑誘發的精神障礙最常見，儘管在世界範圍內仍然相當罕見。

6C4A 尼古丁使用所致障礙：尼古丁使用所致障礙以尼古丁的使用模式和後果為特徵。尼古丁是菸草植物菸草（*Nicotiana tabacum*）中產生依賴性的活性成分。尼古丁主要透過吸煙使用。電子香菸也越來越多地使用尼古丁，這種香菸將溶解在載體溶劑中的尼古丁蒸發吸入（即「霧化」）。煙鬥吸菸、咀嚼菸草和吸食鼻煙是次要的使用方式。尼古丁是一種極易上癮的化合物，是繼咖啡因和酒精之後全球第三常用的精神活性物質。尼古丁依賴症和尼古丁戒斷症都有詳細描述，尼古丁引發的精神障礙也被認可。

6C4B 揮發性吸入劑使用所致障礙：揮發性吸入劑使用所致障礙是以使用揮發性吸入劑的模式和後果為特徵的。揮發性吸入劑包括一系列在環境溫度下處於氣態或蒸氣態的化合物，其中包括各種有機溶劑、膠水、汽油（汽油）、亞硝酸鹽和氣體，如一氧化二氮、三氯乙烷、丁烷、甲苯、碳氟化合物、乙醚和氟烷。它們具有各種藥理特性，但主要是中樞神經系統抑制劑，許多還具有血管活性作用。這些藥物往往為年輕人所使用，在難以或無法獲得替代性精神活性物質時可能使用。揮發性吸入劑中毒已被公認。揮發性吸入劑具有產生依賴性特性，揮發性吸入劑依賴和揮發性吸入劑戒斷已得到確認，但在世界範圍內相對不常見。對揮發性吸入劑引起的精神障礙也有描述。它們也可能導致神經認知障礙，包括癡呆症。

6C4C MDMA 或相關藥物（包括 MDA）使用所致障礙：MDMA 或相關藥物（包括 MDA）使用所致障礙以使用 MDMA 或相關藥物的模式和後果為特徵。 MDMA 是亞甲基二氧基甲基苯丙胺，在許多國家尤其是年輕人中都是常見的濫用藥物。主要以片劑形式出現，被稱為“搖頭丸”。從藥理上講，搖頭丸具有興奮劑和致幻劑特性，這些特性鼓勵年輕人使用搖頭丸進行社交和其他互動。考慮到搖頭丸在許多國家和許多青少年群體中的廣泛流行，搖頭丸及相關藥物依賴和搖頭丸及相關藥物戒斷相對來說並不常見。使用亞甲基二氧基甲基安非他命可能導致藥物性精神障礙。搖頭丸有幾種類似物，包括 MDA（亞甲基二氧基苯丙胺）。

6C4D 分離性藥物（包括氯胺酮或苯環利定 PCP）使用所致障礙：因使用包括氯胺酮和苯環利定（PCP）在內的分離性藥物所致障礙以使用解離藥物的模式和後果為特徵。解離藥物包括氯胺酮和苯環利定（PCP）及其化學類似物（相對罕見）。氯胺酮是一種靜脈注射麻醉劑，廣泛用於中低收入國家，特別是非洲，以及緊急情況下。氯胺酮也被評估用於治療某些精神疾病（如抗藥性憂鬱障礙）。在許多國家，氯胺酮也是一種廣泛使用的非醫用藥物，可透過口服、鼻飼或注射途徑服用。它產生一種欣快感，但根據劑量不同，出現幻覺和分離被認為是令人不快的副作用。苯環利定在全球分佈較為有限，也有欣快和解離作用。使用這種藥物可能導致與個人特徵不符的怪異行為，包括自殘。解離性藥物依賴被描述為一種戒斷綜合徵，但大多數權威並不認可。幾種由解離性藥物引發的精神障礙已被公認。

6C4E 其他特指的精神活性物質（包括治療藥物）使用所致障礙：因使用其他特指精神活性物質（包括藥物）所致的失調，其特徵是精神活性物質的模式和後果，這些物質未被列入在具體確定的主要物質類別中。例如阿拉伯茶、抗憂鬱藥、具有抗膽鹼能特性的藥物（如苯扎托品）和一些抗組織胺。

2.成癮行為所致障礙

6C50 賭博障礙：賭博障礙的特徵是持續或反覆的賭博行為模式，可能是在線（即透過互聯網）或離線，表現為： 1.對賭博的控制能力受損（例如，開始、頻率、強度、持續時間、終止、背景）；2. 越來越重視賭博，使賭博優先於其他生活興趣和日常活動；和 3.儘管發生了負面後果，但仍繼續賭博或升級。 賭博行為模式可能是持續性的，也可能是偶發和反覆出現的。賭博行為對個人、家庭、社會、教育、職業或其他重要領域的功能造成重大困擾或重大損害。賭博行為和其他特徵通常至少在 12 個月內表現明顯，才能被診斷為賭博障礙，但如果符合所有診斷要求且症狀嚴重，所需時間可以縮短。

6C51 遊戲障礙：遊戲障礙的特徵是持續或反覆的遊戲行為模式（「數位遊戲」或「電玩遊戲」），可能是在線（即透過網路）或離線，具體表現如下對遊戲（如開始、頻率、強度、持續時間、終止、背景）的控制能力受損；2. 遊戲的優先級增加，以至於遊戲優先於其他生活興趣和日常活動；以及 3. 儘管出現了負面影響，但遊戲優先於其他生活興趣和日常活動；以及 3. 儘管出現了負面影響，遊戲優先於其他生活興趣和日常活動；以及 3. 儘管出現了負面影響，遊戲優先於其他生活興趣和日常活動；以及 3. 儘管出現了負面影響，遊戲優先於其他生活興趣和日常活動； 遊戲行為模式導致個人、家庭、社會、教育、職業或其他重要功能領域的明顯困擾或嚴重損害。遊戲行為和其他特徵通常至少持續 12 個月才能診斷，儘管如果符合所有診斷要求且症狀嚴重，所需持續時間可能會縮短。

衝動控制障礙.....

6C70 縱火狂：縱火狂的特徵是經常無法控制縱火的強烈衝動，在無明顯動機的情況下（如金錢收益、報復、破壞、政治聲明、吸引註意力或獲得認可），多次縱火或企圖縱火焚燒財產或其他物品。在放火之前，緊張感或情緒亢奮感不斷增強，持續迷戀或專注於火及相關刺激物(例如，看火、生火、迷戀消防設備)，以及在放火、目睹其影響或參與其善後過程中和之後的愉悅、興奮、輕鬆或滿足感。這種行為不能用智障、其他精神和行為障礙或物質中毒來更好地解釋。

6C71 偷竊狂：偷竊狂的特徵是在無明顯動機的情況下（例如，獲得物品並非為個人使用或金錢收益），反覆出現無法控制偷竊物品的強烈衝動。在偷竊之前，緊張感或情緒喚醒感不斷增強，而在偷竊過程中和之後，感到愉悅、興奮、輕鬆或滿足。這種行為不能用智力障礙、其他精神和行為障礙或藥物中毒來更好地解釋。

6C72 強迫性性行為障礙：強迫性性行為障礙的特徵是持續無法控制強烈、重複的性衝動或性慾望，導致重複的性行為。症狀可能包括：重複的性活動成為患者生活的重心，以至於忽視了健康和個人護理或其他興趣、活動和責任；多次試圖大幅減少重複的性行為，但都沒有成功；不顧不良後果繼續重複的性行為，或根本沒有或很少從中獲得滿足感。無法控制強烈的性衝動或性慾望以及由此導致重複的性行為模式在較長時間內（如 6 個月或更長時間）表現出來，並對個人、家庭、社會、教育、職業或其他重要功能領域造成明顯的困擾或重大損害。與道德判斷完全有關的困擾和對性衝動、性慾望或性行為的不認同不足以滿足此要求。

6C73 間歇性暴怒障礙：間歇性暴怒障礙的特徵是反覆出現短暫的言語或肢體攻擊或破壞財產行為，表現為無法控制攻擊性衝動，其爆發強度或攻擊程度與挑釁或引發的社會心理壓力嚴重不成比例。這些症狀不能用其他精神、行為或神經發育障礙來更好地解釋，也不是長期憤怒和易怒模式的一部分（如對立性違抗障礙）。行為模式的嚴重程度足以導致個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域的嚴重受損。

破壞性行為或社交紊亂型障礙.....

6C90 對立違抗障礙：對立性違抗障礙是一種持續性（如 6 個月或以上）的明顯違抗、不服從、挑釁或惡意行為，其發生頻率高於同齡和發育水平相當的個體，而且不局限於與兄弟姐妹的互動。對立性反抗症可能表現為普遍、持續的憤怒或煩躁情緒，常伴隨嚴重脾氣爆發，或表現為任性、好辯和反抗行為。這種行為模式的嚴重程度足以導致其在個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域的嚴重受損。

6C91 反社會品行障礙：反社會品行障礙的特徵是重複且持續的行為模式，在這種行為模式中，他人的基本權利或與年齡相適應的主要社會規範、規則或法律遭到侵犯，如攻擊人或動物；破壞財產；欺騙或偷竊；以及嚴重違反規則。行為模式的嚴重程度足以導致個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要功能領域的重大損害。行為模式必須持續相當長時間（如 12 個月或以上）才能被診斷。因此，孤立的不合群行為或犯罪行為本身並不能作為診斷依據。

人格障礙及相關人格特質.....

6D10 人格障礙：人格障礙的特徵是自我功能方面的問題（如認同、自我價值、自我觀點的準確性、自我導向），和/或人際功能障礙（如發展和維持親密和相互滿意關係的能力、理解他人觀點和處理人際關係衝突的能力），且持續時間較長（如兩年或以上）。這種障礙表現為在認知、情緒體驗、情緒表達和行為模式的不適應。（例如，缺乏彈性或調節能力差），並在一系列個人和社會情境中表現出來（即不局限於特定人際關係或社會角色）。此障礙的行為模式不符合發展規律，也不能主要用社會或文化因素（包括社會政治衝突）來解釋。此障礙對個人、家庭、社會、教育、職業或其他重要領域的功能造成嚴重困擾或重大損害。

6D11 突出的人格特質或模式：特徵領域可用於人格障礙或人格困難，用以描述患者最顯著、人格紊亂最核心的特徵。沒有人格障礙或人格困難個體的正常人格特質領域是連續性的。特徵領域不是診斷類別，而是代表一系列與人格結構對應的向度。可使用盡可能多的特徵領域來描述人格功能。人格紊亂越嚴重，顯著的特質領域就越多。

性慾倒錯障礙.....

6D30 露陰障礙：露陰障礙的特徵是持續、集中和強烈的性興奮模式--表現為持續的性想法、性幻想、性衝動或性行為--涉及在公共場所向毫無戒備的人暴露自己的生殖器，通常不邀請或無意進行更親密的接觸。此外，要診斷為露陰癖障礙，患者必須對這些想法、幻想或衝動付諸行動，或為此感到明顯痛苦。露陰癖障礙明確排除在相關人員同意下發生的雙方同意的暴露行為，以及社會認可的暴露形式。

6D31 窺陰障礙：窺陰障礙的特徵是持續、集中和強烈的性興奮模式--表現為持續的性想法、性幻想、性衝動或性行為--涉及觀察不知情人的裸體、正在脫衣或正在進行的性行為。此外，要診斷為窺淫障礙，患者必須對這些想法、幻想或衝動付諸行動，或為此感到明顯痛苦。窺淫障礙明確排除了在被觀察者同意的情況下發生的雙方同意的窺淫行為。

6D32 戀童障礙：戀童障礙的特徵是持續、集中和強烈的性喚起模式--表現為持續的性想法、性幻想、性衝動或性行為--涉及青春期前的兒童。此外，為確診戀童障礙，患者必須對這些想法、幻想或衝動付諸行動，或明顯感到痛苦。這種診斷不適用於青春期前或青春期後兒童與年齡相仿的同儕發生的性行為。

6D33 強制性性施虐障礙：強制性性施虐障礙的特徵是持續、集中和強烈的性興奮模式--表現為持續的性想法、性幻想、性衝動或性行為--涉及對非自願的人造成身心痛苦。此外，要診斷為強制性性施虐障礙，患者必須對這些想法、幻想或衝動付諸行動，或明顯感到痛苦。強迫性施虐障礙明確排除了自願性施虐和受虐。

6D34 摩擦障礙：摩擦障礙的特徵是持續、集中和強烈的性興奮模式，表現為持續的性想法、性幻想、性衝動或性行為，包括在擁擠的公共場所觸摸或摩擦未經同意的人。此外，要診斷為“摩擦障礙”，患者必須對這些想法、幻想或衝動付諸行動，或為此感到明顯痛苦。摩擦障礙明確排除在當事人同意的情況下發生的觸摸或摩擦。

6D35 涉及非自願對象的其他性慾倒錯障礙：其他涉及非自願對象的性慾倒錯障礙的特徵是持續且強烈的非典型性興奮模式--表現為性想法、性幻想、性衝動或性行為--其中性興奮模式的焦點涉及不願或不能同意的其他人，但在任何其他已命名的性慾障礙類別（例如涉及屍體或動物的性興奮模式）中無具體描述。患者必須對這些想法、幻想或衝動付諸行動，或明顯感到痛苦。該障礙明確排除了在相關人員同意的情況下發生的性行為，前提是他們被認為有能力表示同意。

6D36 涉及自身或自願對象的性慾倒錯障礙：涉及自身或自願對象的性慾倒錯障礙的特徵是持續而強烈的非典型性興奮模式--表現為性想法、性幻想、性衝動或性行為--涉及雙方同意的成年人或單獨行為。必須具備以下兩個要素之一： 1) 此人對喚醒模式的性質感到明顯痛苦，而這種痛苦並不僅僅是他人拒絕或擔心拒絕這種喚醒模式的結果；或 2) 性慾倒錯行為的性質涉及對個人或伴侶造成傷害或死亡的重大風險（例如戀窒息癖）。

做作性障礙.....

6D50 孟喬森症候群：對自身的做作性障礙的特徵是假裝、偽造或誘發與已識別的欺騙有關的醫學、心理或行為徵兆和症狀或傷害。如果已經存在失調或疾病，患者故意加重現有症狀，或偽造或誘發更多症狀。個人根據假裝、偽造或自我誘發的症狀、體徵或傷害尋求治療或以其他方式表現自己生病、受傷或受損。欺騙行為並非完全出於明顯的外部回報或激勵（如獲得殘疾補助或逃避刑事起訴）。這與「詐病」不同，「詐病」行為的動機是明顯的外在回報或激勵。

6D51 代理型孟喬森症候群：對他人做作性障礙的診斷是對假裝、偽造或誘發他人症狀的人，而不是對有這些症狀的人。有時，此人會誘發或偽造寵物的症狀而不是其他人的症狀。

神經認知障礙.....

6D70 譫妄：譫妄的特徵是在短時間內出現注意力、定向力和意識障礙，通常表現為明顯的意識混亂或全面神經認知障礙，症狀短暫，可能因潛在病因而波動。譫妄通常包括行為和情緒障礙，也可能包括多個認知領域的損害。也可能出現睡眠-覺醒週期紊亂，包括急性發作時覺醒減少或睡眠-覺醒週期逆轉時完全失眠。譫妄可能是由未分類於精神、行為或神經發育障礙的疾病的直接生理影響引起，也可能由某種物質或藥物的直接生理影響（包括停藥）引起，也可能由多種或未知病因引起。

6D71 輕度神經認知障礙：輕度神經認知障礙的特徵是，相對於個人的年齡和病前的一般認知功能水平而言，在一個或多個認知領域出現輕度損傷，這代表了個體先前功能水平的下降。診斷是基於患者、資訊提供者或臨床觀察的報告，並附有透過量化臨床評估或標準化認知測試得出的認知功能受損的客觀證據。認知功能障礙的嚴重程度不足以嚴重影響患者從事與個人、家庭、社交、教育和/或職業功能或其他重要功能領域相關活動的能力。認知障礙並非正常老化所致，可能是靜態的、漸進的，也可能基於原因或治療而解決或改善。認知障礙可能是由於根本的神經系統獲得性疾病、創傷、感染或其他影響大腦的疾病過程、使用特定物質或藥物、營養缺乏或接觸毒素所致，也可能病因未定。功能障礙並非由目前藥物中毒或戒斷所致。

6D72 遺忘障礙：遺忘障礙的特徵是，在沒有其他明顯認知障礙的情況下，相對於預期年齡和病前認知功能的一般水平，記憶力明顯減退，這表明患者的功能水平比以前有所下降。表現為獲取、學習和/或保留新資訊方面的缺陷，可能包括在無意識障礙、精神狀態改變或譫妄的情況下無法回憶起先前學過的資訊。近期記憶通常比遠期記憶受到的干擾更大，而立即回想有限資訊的能力通常相對較好。記憶障礙嚴重到足以導致個人、家庭、社交、教育、職業或其他重要領域的功能嚴重受損。推測原因可能是神經系統獲得性疾病、創傷、感染或其他影響大腦的疾病過程、使用特定物質或藥物、營養缺乏或接觸毒素，或病因未定。功能障礙並非由於目前藥物中毒或戒斷所致。

癡呆

6D80 阿茲海默症所致癡呆：阿茲海默症所致癡呆是最常見的癡呆形式。起病隱匿，通常以記憶障礙為初始主訴症狀。其特徵性病程是認知功能從以前水準緩慢穩定地下降，隨病情發展，出現其他認知領域（如執行功能、注意力、語言、社會認知和判斷、精神運動速度、視覺感知或視覺空間能力）的損害。阿茲海默症所致癡呆在發病初期可能伴隨精神和行為症狀，如情緒低落和冷漠，後期可能伴隨精神症狀、易激惹、攻擊性、意識模糊、步態和行動異常以及癲癇發作。基因檢測陽性、家族史和認知能力逐漸下降都提示患有阿茲海默症所致癡呆。

6D81 腦血管病變所致癡呆：因腦血管疾病（缺血性或出血性）導致腦實質損傷引起的失智症。認知障礙的出現在時間上與一次或多次血管事件有關。認知能力下降通常在資訊處理速度、複雜注意力和額葉執行功能方面最為突出。根據病史、身體檢查和神經影像學檢查，有證據顯示有腦血管疾病，足以解釋神經認知障礙。

6D82 路易氏體病所致癡呆：路易氏體病患者在出現運動性帕金森症狀之前或之後一年內出現的癡呆症。以存在路易氏體為特徵，路易氏體是腦幹、邊緣區、前腦和新皮質中含有 α 突觸核蛋白和泛素的神經元間內包涵體。發病隱匿，常伴隨注意力和執行功能障礙。這些認知障礙通常伴隨視覺幻覺和快速動眼睡眠行為障礙症狀。也可能出現其他感官模式的幻覺、憂鬱症狀和妄想。症狀表現通常在數天內變化很大，因此需要進行縱向評估並與譫妄相鑑別。在認知症狀出現後約 1 年內常出現自發性帕金森氏症的情況。

6D83 額顳失智症：額顳失智症（FTD）是一組主要影響額葉和顳葉的原發性神經退化性疾病。此病通常起病隱匿，病程逐漸加重。目前已描述了幾種綜合徵變異（其中一些已確定有遺傳基礎或家族性），包括主要表現為明顯的人格和行為改變（如執行功能障礙、冷漠、社會認知退化、重複行為和飲食改變）、主要表現為語言缺陷（包括語義、語法失能/非流暢性和 Logopenic 型），主要與運動有關的神經節萎縮性神經性或神經性神經性多發性硬化症、進行性神經性神經性多發性硬化症、神經系統萎縮性神經性神經性）。記憶功能通常保持相對完整，特別是在疾病的早期階段。

6D84 精神活性物質（包括治療藥物）所致癡呆：精神活性物質包括藥物所致癡呆的形式可判斷為物質使用的直接結果，且持續時間明顯超過物質中毒或戒斷時的認知損害持續時間。物質使用的量和持續時間足以造成認知損害。認知損害不能被非物質所致障礙或疾病解釋，例如由分類於他處的疾病所致癡呆。

6D85 分類於他處的疾病所致癡呆

6D85.0 帕金森氏症所致癡呆：帕金森氏症所致癡呆症發生在特發性帕金森氏症患者中，其特徵是注意力、記憶力、執行力和視覺空間功能受損。也可能出現情緒變化、冷漠和幻覺等精神和行為症狀。發病隱匿，症狀逐漸加重。

6D85.1 亨廷頓舞蹈症性癡呆：亨廷頓舞蹈症性癡呆症是廣泛性腦退化的一部分，由 HTT 基因三核苷酸重複擴展所致，為體染色體顯性遺傳。發病隱襲，常見於三、四十歲者，緩慢進展。起始症狀常包括執行功能損害，而少見記憶損害，隨後出現亨丁頓舞蹈症特徵性的運動損害（運動遲緩和舞蹈症）。

6D85.2 暴露於重金屬或其他毒素所致癡呆：因接觸重金屬和其他毒素所致癡呆症是由於接觸了特定重金屬，如透析水中的鋁、鉛、汞或錳。暴露於重金屬和其他毒素導致失智症的特徵性認知障礙取決於患者接觸的特定重金屬或毒素，但也可能影響任何認知領域。症狀的發作與接觸有關，尤其是急性接觸時，進展可能很快。在許多情況下，一旦發現並停止接觸，症狀可逆。腦部影像或神經電生理檢測等檢查可能出現異常。鉛中毒與腦部造影異常有關，包括廣泛鈣化和腦室周圍白質、基底節-下丘腦和腦橋的 MRI T2 加權影像訊號增強。鋁中毒導致的癡呆可能表現出特徵性陣發性高壓 δ 腦電圖變化。檢查還可發現其他特徵，如鉛、砷或汞中毒引起的周邊神經病變。

6D85.3 人類免疫缺乏病毒所致癡呆：人類免疫缺乏病毒所致癡呆在 HIV 疾病進展中，沒有 HIV 感染以外的疾病或問題能解釋其臨床特徵。雖然根據 HIV 病理過程可能存在各種認知缺陷，但典型缺陷為皮質下認知模式，包括執行功能、處理速度、注意力、新知識學習損害。人類免疫缺乏病毒所致癡呆的病程變化多樣，包括臨床緩解、功能逐漸下降或增加、症狀波動。隨抗逆轉錄病毒藥物的出現，罕見認知功能快速下降。

6D85.4 多發性硬化所致癡呆：多發性硬化引起的癡呆症是一種神經退化性疾病，是由多發性硬化這種脫髓鞘疾病對大腦的影響所致。症狀起病隱匿，並非繼發於原發性疾病（即多發性硬化症）的功能障礙。認知障礙因脫髓鞘的部位而異，但通常包括處理速度、記憶力、注意力和執行功能等方面的缺陷。

6D85.5 朊病毒病所致癡呆：朊病毒病所致失智症是一種原發性神經退化性疾病，由一組海綿狀腦病變引起，其原因是朊病毒蛋白在大腦中異常累積。這些疾病可能是散發性，或遺傳性（由朊病毒蛋白基因突變引起）或傳播性（從感染者獲得）。發病隱匿，症狀和功能損害發展迅速，主要表現為認知缺陷、共濟失調和運動症狀（肌陣攣、舞蹈症或肌張力失調）。診斷通常基於腦部造影研究、脊髓液中存在特徵性蛋白質、腦電圖或基因檢測。

6D85.6 正常壓力腦積水所致癡呆：正常壓力腦積水所致失智症是由特發性、非阻塞性原因導致腦脊髓液在大腦中過度積聚，但也可能繼發於出血、感染或發炎。病情發展漸進，但介入（如分流術）可能改善症狀，尤其在病程早期進行幹預。典型的認知障礙包括處理速度下降、執行功能和注意力缺陷。這些症狀通常也伴隨步態異常和尿失禁。通常需要透過腦部影像顯示腦室容量和腦移位特徵，以確診該疾病。

6D85.7 頭部損傷所致癡呆：頭部損傷所致癡呆是外力直接或間接損傷腦組織所致癡呆。腦部外傷可能導致意識喪失，遺忘，定向障礙和意識混亂，神經體徵。頭部損傷所致癡呆的症狀特徵應在外傷後立即出現，或在患者恢復意識後出現，並持續超過急性損傷後期。認知缺陷會根據受影響的不同腦區及損害嚴重程度而變化，可包括注意、記憶、執行功能、人格、處理速度、社會認知和語言能力的損害。

6D85.8 糙皮病所致癡呆：糙皮症所致癡呆症是由於飲食中持續缺乏維生素 B3（菸鹼酸）或色氨酸，或因疾病（如克隆氏症）或某些藥物（如異煙肼）的影響導致胃腸道吸收不良。糙皮症的核心症狀包括皮膚病（對陽光敏感、皮損、掉髮和水腫）和腹瀉。如果長期營養缺乏，出現認知症狀，包括攻擊性、運動障礙（共濟失調和煩躁不安）、意識模糊和虛弱。補充營養（如菸鹼酸）治療通常可使症狀逆轉。

6D85.9 唐氏症所致癡呆：唐氏症所致癡呆是一種神經退化性疾病，與澱粉樣前驅蛋白（APP）的異常增生和累積導致 β -澱粉狀蛋白塊和 tau 纏結形成有關。APP 基因表現增加的原因是其位於 21 號染色體上，而唐氏症患者的 21 號染色體是異常的三倍體。認知缺陷和神經病理學特徵與阿茲海默症相似。此病通常在患者四十歲後發病，功能逐漸減退，50% 或更多的唐氏症患者受到影響。

6D86 癡呆引起的行為或精神紊亂：除癡呆症特有的認知障礙外，臨床現況包括：(1) 顯著的妄想、幻覺(2) 憂鬱心境，高漲心境或易激惹心境(3) 焦慮或擔心(4) 情感淡漠或興趣缺乏(5) 過度精神運動活動伴隨緊張度增加、敵意或暴力行為(6) 無視社會常規，衝動型，風險評估能力差(7) 漫遊症狀，導致患者有受傷的風險

與妊娠、分娩或產褥期有關的精神或行為障礙.....

6E20 與懷孕、分娩或產褥期相關的精神或行為障礙，不伴隨精神病症狀：與妊娠、分娩（在產後 6 週內出現）相關的綜合徵，包括顯著的精神和行為特徵，最常見憂鬱症狀。綜合徵不包括妄想、幻覺或及其他精神病性症狀。若症狀符合某一特定精神障礙的診斷要求，應同時診斷。此診斷不應用於描述不符合憂鬱發作診斷要求的輕度或短暫的憂鬱症狀，後者可能在產後很快出現（所謂的「產後憂鬱」）。

6E21 與懷孕、分娩或產褥期相關精神或行為障礙，伴隨精神病症狀：與懷孕、分娩（產後 6 週內出現）相關的綜合徵，包括顯著的精神和行為特徵，包括妄想、幻覺或及其他精神病性症狀。心境症狀（憂鬱和/或躁狂）也常存在。若症狀符合某一特定精神障礙的診斷要求，應同時診斷。